7.3.1. 환자안전사건 관리

제 정 일	2008.09.	최 종 개 정 일	2025.03.25.	최 종 검 토 일	2025.03.25.
담 당 부 서	의료질향상 및 환자안전위원회				
유 관 부 서					

관 련 기 준	4주기 의료기관인증기준: 7.3 환자안전사건 관리 JCI Standard 7th Edition: APR.9, 11, QPS.7, 7.1, 8, GLD.1.2, 4, 4.1, 13, 13.1

제1조 (목적)

1. 환자안전사건의 정의, 관리 및 보고 절차 등을 마련하고 이를 통하여 효과적인 환자안전사건의 파악, 관리 및 예방을 하기 위함이다.

제2조 (정의)

1. 환자안전사건: 질병이나 치료경과와 무관하게 업무절차 수행과정의 실수나 문제로 인해 환자에게 위해 또는 위해가 발생될 뻔한 사건을 의미
2. 환자안전사건 분류
   1) 적신호 사건(Sentinel Event)
      (1) 심각도 수준 5, 6 level
      (2) 환자 질병 및 기저 질환과 관련 없는 예상치 못한 사망(분만 중 모성 사망, 만삭아 사망 포함) 또는 주요 기능의 영구적 손실
      (3) 잘못된 환자, 잘못된 부위, 잘못된 시술을 포함한 침습적 시술/수술
      (4) 시술/수술 후 이물질 잔존
      (5) 혈액/수혈 및 오염된 장기/조직의 이식을 통한 만성 또는 치명적인 질환/질병의 전염
      (6) 용혈성 수혈반응
      (7) 중증 신생아 고빌리루빈혈증(Bilirubin > 30mg/dl)
      (8) 환자의 자살(퇴원 후 72시간 이내 자살 포함)
      (9) 성폭행, 사망이나 심각한 피해로 이어진 폭행, 살인, 납치
      (10) 무단 이탈 후 사망 또는 심각한 피해
      (11) 영아 유괴, 잘못된 가족에게 신생아 퇴원
      (12) 방사선 치료 시 누적 선량 1,500rads초과, 치료 부위 오류, 계획 선량보다 25%이상 초과 조사
      (13) 치료 중 발생하는 화재, 예상치 못한 여기나 불꽃
      (14) 심각한 무성 이환율(Morbidity)
   2) 위해사건(Adverse Event): 치료과정이나 업무수행 중 발생된 의도하지 않은 실수나 오류가 환자에게 도달하여 추가적인 치료가 필요해진 경우
   3) 무해사건(No Harm Event): 사건이 발생하였으나 환자에게 해가 되지 않은 사건
   4) 근접오류(Near Miss): 치료과정이나 업무수행 중 발생된 의도하지 않은 실수나 오류가

시기적절한 중재에 의해 환자에게 도달하지 않은 경우

3. Safety Level(심각도 수준)

Safety Level		환자안전사건
Level 0	치료과정이나 업무수행 중 발생된 의도하지 않은 실수나 오류가 시기 적절한 중재에 의해 환자에게 도달하지 않은 경우	근접오류 **(Near Miss)**
Level 1	사건이 발생했으나 환자는 손상이 없음	무해사건 **(No Harm Event)**
Level 2	사건 발생으로 환자상태에 대한 평가요구가 증가되었으나, 활력징후에는 변화가 없고, 손상도 없음	
Level 3	사건 발생으로 환자는 일시적 손상을 입었으나, 치료나 중재가 필요함	위해사건 **(Adverse Event)**
Level 4	사건 발생으로 환자는 일시적 손상을 입었으며, 그 결과로 입원이 필요하거나 재원 기간이 늘어남	
Level 5	사건 발생으로 환자는 영구적 손상을 입었거나 거의 죽음에 이르는 상태가 됨	적신호 사건 **(Sentinel Event)**
Level 6	사건 발생으로 환자가 사망함	

제3조 (절차)

1. 환자안전사건 보고

1) 내부보고

(1) 환자안전사건 보고는 의료진이 할 수 있으며, 환자안전보고체계에 따라 전산 또는 서면, 구두보고를 통해 이루어진다. 전산보고는 U-Severance를 통해 접수될 수 있으며, 서면보고는 환자안전보고서를 통해 접수될 수 있다. 구두보고는 전화 또는 진료혁신센터 환자안전파트 방문을 통하여 이루어진다.

① 의료진의 보고 방법

a. 전화: 원내 85103으로 신고

b. 방문: 진료혁신센터 환자안전파트 방문

c. 전산: u-Severance → 환자안전 사건보고

d. 서면: [환자안전 보고서] 작성 후 제출

(2) 환자와 연관된 사건은 즉시 주치의(담당교수) 및 관련 부서장에게 보고하고, 진료혁신센터 환자안전파트에 보고한다.

① 적신호 사건은 사건 발생 또는 인지 후 24시간 이내에 보고한다.

a. 주치의(담당교수)는 적신호 사건 발생 시 환자 및 보호자에게 진료과정에서 발생한 내용, 치료계획 등 관련 정보를 제공한다.

② 적신호 사건 이외 환자안전사건(위해사건, 무해사건, 근접오류)은 발생 또는 인지 후 7일 이내에 보고한다.

2) 외부보고

(1) 환자안전파트의 전담인력은 보고된 사건을 검토하여 환자안전보고학습시스템에 자율보고 하거나, 중대한 환자안전사고 의무 보고 대상인 경우, 이를 의료기관의

장에게 보고하여 보건복지부장관에게 지체없이 보고하도록 한다.

① 중대한 환자안전사고 의무보고 대상

a. 설명하고 동의를 받은 내용과 다른 내용의 수술, 수혈, 전신마취로 환자가 사망하거나 심각한 신체적 · 정신적 손상을 입은 경우

b. 진료기록과 다른 의약품이 투여되거나 용량 또는 경로가 진료기록과 다르게 투여되어 환자가 사망하거나 심각한 신체적 · 정신적 손상을 입은 경우

c. 다른 환자나 부위의 수술로 환자안전사고가 발생한 경우

d. 의료기관 내에서 신체적 폭력으로 인해 환자가 사망하거나 심각한 신체적 · 정신적 손상을 입은 경우

2. 환자안전사건 분석

1) 진료혁신센터 환자안전파트 담당자는 보고된 환자안전사건을 분석한다.

(1) 의무기록 검토

(2) 관련직원 및 부서장 면담

(3) 문헌고찰

(4) 지침/프로세스 검토

(5) 시설/장비 검토

(6) 의료진 및 전문가 자문

2) 적신호 사건 발생 시 아래의 절차에 따라 관리한다.

(1) 적신호 사건은 사건 발생일 또는 사건을 인지한 날로부터 45일 이내에 근본원인분석(Root Cause Analysis) 시행과 개선활동을 수립하며, 다음의 내용을 포함한다.

① 시스템과 프로세스, 적신호 사건의 근본원인에 대한 분석

② 임상 프로세스에서의 특수 요인과 행정 프로세스에서의 일반적인 요인 분석

③ 향후 재발 가능성을 최소화시키기 위한 활동 파악

④ 개선을 위한 방법 및 근거자료를 포함 계획 수립

⑤ 개선 활동 평가

3) 유형 분석 수행: 적신호사건 외의 사건은 보고 데이터를 유형별로 분류하고 분석한다.

4) 다음의 경우, 필요 시 환자안전소위원회를 개최한다.

(1) 예상하지 못한 사망 또는 심각한 주요 기능의 손실을 포함한 경우

(2) 진료 및 치료의 통상적인 절차로부터 심각하게 벗어난 경우

(3) 기타 진료혁신센터 환자안전파트에서 논의가 필요하다 판단한 경우

① 환자안전소위원회 구성 및 논의 사항

a. 진료혁신부원장, 환자안전파트, 법무팀으로 구성되며, 소위원회 개최 시 관련 의료진의 참석을 요청한다.

b. 사건 발생 원인, 환자 상태, 사건 공개(Disclosure) 여부, 공개의 주체, 합의 사항, 사후 진행방향에 대해 논의하며, 사건의 재발방지를 위하여 개선방안을 도출 및 개선 활동을 수행한다.

c. 환자안전소위원회의 논의 결과는 병원운영위원회에 보고한다.

3. 데이터 분석

1) 바람직하지 않은 동향과 명확한 편차가 나타날 경우, 데이터를 분석한다.

(1) 데이터 수집 프로세스가 개발되고 구현된다.

(2) 위해한 수준이나 추세가 발생할 경우 데이터 심층 분석을 시행한다.

(3) 다음과 같은 데이터를 수집 및 분석한다.

① 수혈 부작용

② 심각한 약물위해사건 (Drug Adverse Event)

③ 투약 오류

④ 수술 전, 후 진단이 불일치하는 경우

⑤ 진정 및 마취 시 발생한 위해사건, 혹은 유사 위해사건

⑥ 환자 확인(identification)과 관련된 위해 사건

⑦ 기타 환자안전사건으로 보고되는 사건

(4) 질향상과 환자안전을 위해 분석된 결과를 사용한다

(5) 데이터 결과는 질향상 및 환자안전 프로그램의 일부로 병원운영위원회에 보고한다.

4. 개선활동 수행

1) 적신호 사건 및 환자안전사건 발생 시(위해사건, 무해사건, 근접오류) 유형을 분석하고 분석 결과의 우선순위에 따라 개선활동을 수행한다.

5. 경영진 보고 및 관련 직원 공유

1) 절차에 따라 보고된 환자안전사건 결과를 의료질향상 및 환자안전위원회와 병원운영위원회에 보고하고, 관련 직원과 공유한다.

6. 적신호사건 발생 시 관련 정보제공

1) 환자 및 보호자와의 의사소통 시 [부록1. 환자안전의사소통 프로세스] 및 [부록2. 중대한 환자안전사건 관련 환자 및 보호자 분쟁 대응 프로세스]에 따른다.

7. 환자안전 주의경보 발령 시 관련 직원 공유

1) 국가에서 발령하는 환자안전 주의경보 및 의료기관 차원에서 선정한 환자안전 주의경보를 관련 직원에게 원내 메일과 게시판을 이용하여 공유한다.

8. 책임과 의무

1) 직원: 직원은 환자안전과 연관된 사건을 즉시 주치의(담당교수)및 관련 부서장에게 보고한다.

2) 진료혁신센터 환자안전파트: 보고된 사건에 대해 조사한다.

3) 의료질향상 및 환자안전위원회: 병원 내 위험관리에 대한 실질적인 책임을 갖고 관련 내규 및 절차, 위험관리 프로그램을 활용하여 병원 전체에서 효율적인 위험관리가 시행되도록 한다. 소위원회를 두어 업무를 분담할 수 있다.

4) 병원운영위원회

(1) 병원운영위원회는 우선적으로 개선하고 실행해야 하는 항목을 선택하며, 위험 감소 활동을 위임하고 감독할 책임을 갖는다.

(2) 위험관리 프로그램을 승인하고, 위험관리 및 대책행위에 대한 총체적인 책임을 갖는다.

9. 환자안전보고체계

제4조 (부록)

1. 환자안전의사소통 프로세스
2. 중대한 환자안전사건 관련 환자 및 보호자 분쟁 대응 프로세스

제5조 (참고)

내규의 제 · 개정 이력

제1조 (내규의 제정 및 시행)

1. 이 내규는 2008년 9월부터 시행한다.

제2조 (내규의 전면개정 및 시행)

1. 이 내규는 2025년 3월 25일부터 시행한다.

제3조 (내규의 개정)

승 인: 세브란스병원장 이 강 영 (인)